

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	疥瘡 Scabies				
編號	A31000-Q03-W-J04	制定者	REH 張淑玲	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.1 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解疥瘡的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，保護院內病人、家屬、員工，避免交互感染，對此疾病照護能有所依循，提供適切合宜之護理照護。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

指疥蟲寄生人體皮膚而引起的傳染性疾病，疥蟲鑽入皮膚內，造成肉眼可以看到的丘疹與小疱之皮膚病變，極易傳染給他人。

（二）症狀

- 1.劇烈搔癢：尤其夜間明顯劇癢。
- 2.在皮膚上發生散立性孤立性粟粒大小之小丘疹，其色微紅至深紅，頂尖可見小泡或小膿泡。
- 3.漸進式發疹或發癢，病灶好發於指間、腋下、耳後等皮膚皺摺處。
- 4.皮膚上有丘疹與小疱，呈現棕色或黑色的線狀隧道，為疥隧道(burrow)。
- 5.一般少見於顏面、頭皮等處。
- 6.常病變發生於所謂皮膚柔軟部，如指間、掌緣、腕關節尺側、肘關節屈側、腋窩前後緣、臍圍、軀幹腰帶部份、臀下部、女性的乳房下緣，特別是乳頭；男性外陰部及其周圍皮膚，特別是陰囊、包皮、龜頭等；但幼兒與大人不同，皮

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/9

疹可能出現於頭、顏面、頸或掌蹠等。

(三) 傳染方式(Mode of transmission)

- 1.疥蟲會透過身體皮膚的頻繁緊密接觸（如：共用毛巾、被單、棉被等）而迅速擴散傳播感染，所以疥瘡傳染性很高，沒有年齡的限制。
- 2.主要的感染途徑為接觸傳染。
- 3.患者應格外注重個人清潔衛生。

(四) 常見檢查

- 1.皮膚刮屑氫氧化鉀顯微鏡檢查(skin scraping)。
- 2.墨水染色檢查。
- 3.四環黴素染色檢查。
- 4.皮膚切片檢查。

(五) 常見治療

1.局部性治療

5% permethrin(Elimate®)是安全且有效的，建議夜間塗抹，讓藥物停留在皮膚上一整晚後再洗淨，如有需要，一周後可再塗抹。副作用為過敏和刺激後接觸性的皮膚炎，但發生機率較 Lindane 低且毒性低。

2.全身性治療

- (1)ivermectin(Stromectol® Mectizan®)是有效且安全的治療疥瘡的口服藥物。口服劑量為 ivermectin 0.2mg/kg，建議在飯前使用，肝功能不良的病患須慎用。
- (2)口服 ivermectin 抗組織胺藥物可用來緩解搔癢的症狀。
- (3)長期使用類固醇會使得病人感染疥瘡後出現不典型的病灶而造成診斷上的延遲，也因此成為患者二年內再次被診斷感染疥瘡最重要的風險因子；相對於未長期使用類固醇的疥瘡病人，其風險高達四倍，故應與醫師討論藥物治療方向及加強防範。

(六) 護理問題

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/9

1.組織（皮膚）狀態不完整／疥蟲感染。

2.知識缺失／缺乏正確的資訊。

3.情境性低自尊／疥蟲感染。

4.易感染／疥蟲感染。

（七）護理措施

疥瘡相關防護可參考院內感染管制委員會訂定之疥瘡之感染管制政策 212070-ACA-P-012 管制政策。以下針對護理問題提供護理措施參考：

1.組織（皮膚）狀態不完整／與疥蟲感染有關

(1)採接觸性隔離：工作人員、家屬探視時，應穿隔離衣、戴手套，並減少訪客探視的時間及次數。衛教家屬配合接觸隔離政策，以降低被感染機會。

(2)護理人員執行照護後應確實執行洗手技術，並採取集中護理。

(3)臨床照護病人或接觸環境後，落實洗手五時機之遵守。

(4)衛教病人剪短指甲，以避免抓傷皮膚造成感染。

(5)給予感染病人抗疥瘡藥物塗抹，並衛教正確使用方式。

(6)觀察病人皮膚變化及紅疹情形，異常情況需通知醫師並記錄。

(7)若身上有傷口，應每日觀察傷口變化並協助更換敷料。

(8)教導照顧者傷口照護方式及感染注意事項，必要時告知醫療人員。

2.知識缺失／缺乏正確的資訊

(1)衛教疥瘡的傳染途徑及症狀，並提供照顧者衛教單張。

(2)應限制家屬與訪客探視時間，工作人員、家屬與訪客探視病人時，應穿隔離衣、戴手套，探視完畢應洗手，減少接觸機會。

(3)衛教家屬用物處理：

A.衛教病人及家屬使用過的床褥、毛毯、鞋子等能水洗衣物以攝氏 60°C 熱水煮 10 分鐘以上或用熨斗燙；無法水洗用物可以放入雙層感染性塑膠袋密封後靜置一星期。

B.衛教病人用品之消毒：與病人接觸過不能水洗之物品，應依循廠商建議進

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/9

行清潔消毒。

C.病人用品應個別化，避免交互使用。

3. 情境性低自尊／疥蟲感染採接觸性隔離

- (1) 保持不批評及同理的態度。
- (2) 主動發現病人需求及問題，協助其問題解決。
- (3) 引導病人說出想法與感覺，必要時提供會診及轉介。
- (4) 主動傾聽病人與家屬感覺，以同理態度面對病人。
- (5) 維持一致性及真誠的態度。
- (6) 教導病人使用正向態度面對自己。
- (7) 協助病人分析情境中之因素，以澄清價值並矯正扭曲之感受。
- (8) 協助病人調適失落、壓力或環境因素造成的低自尊。
- (9) 協助病人自己解決問題，並辨認能幫助重建自尊活動。
- (10) 給予正確觀念及治療方向，讓病人免於恐懼或害怕中。
- (11) 討論病情或交接班時應注意維護病人隱私。

4. 易感染／疥蟲感染

- (1) 監測生命徵象及檢驗值異常感染數值。
- (2) 教導家屬任何感染徵象及症狀，隨時通知醫護人員。
- (3) 落實洗手五時機，嚴格遵守感染管制隔離防護措施，避免交互感染。
- (4) 每日執行沐浴後，應落實全身藥物塗擦。
- (5) 必要時應保護病人避免因搔癢導致抓傷而有傷口產生。
- (6) 執行照護時，照顧者應戴手套執行。
- (7) 接觸病人應穿著隔離衣。

(八) 衛教指導

1. 衛教病人每天晚上洗澡後使用外用滅疥藥劑，尤其指甲縫、手指、腳趾間、腋下、胸部、陰部、臀部、耳後等皮膚皺摺部位。
2. 使用塗擦之藥物全身塗抹，不可私自停藥。

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/9

- 3.用藥若有任何不適或皮膚紅疹增加，應主動告知醫師。
- 4.衛教病人使用過的床褥、毛毯、鞋子等能水洗衣物以攝氏 60°C 熱水煮 10 分鐘以上或用熨斗燙；不能水洗者（如血壓計、耳溫槍），以塑膠袋密封靜置至少 1 星期或艷陽下曝曬 8 小時以上。
- 5.若需口服疥瘡用藥應經由皮膚科醫師判斷並開立方能進行服用。
- 6.病人的布單、被服要與未感染病人的布單、被服需分開處理。
- 7.傢俱及居家環境，應用漂白水(1,000 ppm)擦拭傢俱及拖地，徹底清潔消毒。
- 8.病人清床原則依院內感染管制指導書內容進行徹底清潔消毒。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一） 院內感染管制指導書（2024 年 5 月 30 日）•疥瘡之感染管制政策，取自院內感染管制指導書 212070-ACA-W-012。
- （二） 謝采恩、蔡貽婷、林佩昭、陳怡晏、陳立樺(2020)•提升隔離病房疥瘡照護正確率•高雄護理雜誌，37(1)，13-24。
- （三） 蔡美娟、詹明錦、林永崇(2020)•運用 TRM 方式處理呼吸照護病人疥瘡感染事件•感染控制雜誌，30(2)，83-92。
- （四） 陳裕芬、陳澄淳、黃惠美(2020)•美國洛杉磯縣公共衛生局急性傳染病控制計畫-2019 醫療機構疥瘡之防治智尹中譯，感染控制雜誌，30(2)，140-147。

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/9

- (五) Sunderkötter, C., Wohlrab, J., & Hamm, H. (2021). Scabies: epidemiology, diagnosis, and treatment. *Deutsches Ärzteblatt International*, 118(41), 695.
- (六) Al-Saadi, I. N. A. (2024). SCABIES: EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS AND TREATMENT. *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, 2(4), 67-71.

七、附件

(略)

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	修訂參考資料。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	常見治療新增 1~3 項說明內容。 衛教病人及家屬使用過的床褥、毛毯、鞋子等能水洗衣物修改以攝氏 60℃ 熱水煮 10 分鐘以上。 參考資料新增：院內感染管制指導書（2013 年 6 月 21 日）・疥瘡之感染管制政策，取自院內感染管制指導書 212070-ECA-P-012。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1. 第三項說明內容修正並新增，治療部分加入實證資料；實證參考依據 Engelman, D., Kiang, K., Chosidow, O., McCarthy, J., Fuller, C., Lammie, P., & Hay, R.,(2013)、Strong, M., Johnstone, P. (2010)。 2. 第六項參考資料更新新增五年內文獻。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	1. 第三項第(三)、(七)目說明內容修正並新增部分內容。 2. 將參考文獻新增於內文中。 3. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.4	1. 第三項第(一)、(二)目加入文獻更新。 2. 藥物治療加入 2016 年實證資料。 3. 第三項第(三)、(五)、(七)、(八)目增刪部份內容。 4. 新增第六項參考文獻資料。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五目之 2(3)、第八目之 4 內容說明文字修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.6	1. 第三項第三目之 3 刪除說明文字內容。 2. 第三項第七目之 2 之(3)之 A 說明文字修訂。 3. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 修改第六項參考文獻資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.7	1. 第三項第五目之 1 錯字修正。 2. 第三項第七目之 4 之(5)文字敘述修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.8	第三項第五目 2-(3)APA 修正。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.9	1. 第三項第六、七目護理問題修訂。 2. 第三項第八目新增說明內容。 3. 第六項參考文獻增減。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	4.0	1. 第三項第七目 2.(3)B.增減內容文字。 2. 第六項參考文獻增減。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。

主題名稱	疥瘡	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-J04	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
115.01.06	4.1	1. 第三項第八目 7 增加內容文字。 2. 第六項參考文獻增減。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。